Processo nº **0057116-29.2020.8.17.2001**

AUTOR: ARIANNA ZOILA OLIVERA SALMON

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

ARIANNA ZOILA OLIVERA SALMON ajuizou ação em face de **BRADESCO SAÚDE S/A**, buscando a condenação da parte demandada a: (***i***) custear as despesas relativas ao tratamento prescrito no laudo médico que apresenta (tratamento com imunoglobulina humana 15 gramas EV); **(ii)** pagar à autora, a título de indenização por danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (***iii***) pagar custas processuais e honorários advocatícios.

Afirma, em síntese, que:

a) é beneficiária de plano de saúde administrado pela demanda, estando com suas obrigações contratuais pontualmente adimplidas, mediante desconto em contracheque;

b) por apresentar aborto de repetição, foi submetida a exame de Cross Match, que resultou em "não reativo", tendo sido diagnosticada com **aloimunidade não reativa**, quadro que lhe vem causando perdas fetais no 1º trimestre;

c) em face do diagnóstico, sua médica assistente prescreveu tratamento com **imunoglobulina humana endovenosa combinada com Clexane**, durante a gestação, para evitar a perda fetal;

d) a clínica Multihemo, ambulatório onde o medicamento seria aplicado, informou à parte autora por telefone acerca da resposta negativa da parte ré em custear o tratamento prescrito, sob a justificativa de **não previsão na Diretriz de Utilização da ANS**, segundo a qual estariam cobertos os fornecimentos apenas em tratamentos de quimioterapia e terapia imunobiológica;

e) não recebeu resposta negativa formal, mas, para fins de demonstração, juntou cópia de negativa da ré em caso análogo;

f) a negativa é ilegal, posto que as complicações gestacionais estão cobertas pela Lei n.º 9.656/1998 (art. 35-C), que rege seu contrato.

Pediu que, em sede de tutela provisória de urgência, fosse a parte demandada compelida a fornecer a medicação indicada no laudo médico (imunoglobulina humana 15 gramas EV), num total de 5 (cinco) doses, a ser

administrada na clínica Multihemo, onde a médica assistente da parte autora a acompanha.

Requereu os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Juntou documentos.

Intimada para comprovar que fazia jus à gratuidade, a parte autora realizou o pagamento das custas judiciais, no valor de R$357,18 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), em 16.09.2020 (ID 68073663).

Intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência, a parte ré pugnou pelo indeferimento do pedido antecipatório (ID 68087633).

Em sede de **contestação** (ID 68815519), sustenta que:

a) a autora é beneficiária de apólice empresarial, tipo Saúde Gr. Especiais, com acomodação em enfermaria, estipulada pelo True Change Tecnologia Ltda, com início de vigência em 22/06/2020;

b) em 01/09/2020, foi a autorização solicitada pela Multihemo para realização de "procedimento 20104383 – Pulsoterapia intravenosa por sessão – ambulat. Para administração a medicação imunoglobina flebogamma 15g", foi negada, sob o fundamento de tratar-se de medicação ambulatorial administrada fora do regime de urgência/emergência;

c) o contrato do qual é beneficiária a parte autora exclui expressamente a cobertura de medicamentos de uso ambulatorial na cláusula 5, que está em absoluta consonância com a previsão do artigo 10, VI, da Lei 9.656/1998;

d) o tratamento solicitado não consta do rol de procedimentos da ANS (Resolução Normativa nº 428) para os casos de quimioterapia ou para terapia imunobiológica;

e) segundo entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o rol da ANS é taxativo;

f) há necessidade de manter equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

g) inexistem danos morais e descabe inversão do ônus da prova.

Juntou documentos.

Por meio da decisão de ID 69887099, este Juízo, **deferindo a tutela de urgência pleiteada**, determinou que parte demandada autorizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, o fornecimento de 5 (cinco) doses da medicação imunoglobulina humana 15 gramas, conforme prescrita pela médica assistente da parte autora (ID 67738872), condicionando o cumprimento da decisão à comprovação do estado de gravidez da autora, considerando que o laudo médico indicava o tratamento durante a gestação.

Intimada, a parte autora juntou novo laudo médico (ID's 70472393 e 70472399).

Por meio do despacho de ID 72089266, este Juízo, concluindo que o laudo apresentado não suprira a determinação judicial de comprovação do estado gestacional, fixou novo prazo para tanto, sob pena de revogação da decisão.

Intimada, a demandante esclareceu, juntando novo laudo médico (ID 72411161), que, para impedir o risco de mais um abortamento, **o tratamento deve em verdade ser iniciado antes do início da gestação, na fase ovulatória**.

Os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 74076852 pela parte demandada restaram rejeitados nos termos da decisão de ID 90063426.

Por meio da petição de ID 80950726, a parte autora informou que recebeu o comunicado de autorização do tratamento com prazo de 30 (trinta) dias, mas, aletando que a medicação precisará ser utilizada em período posterior ao fixado pela ré, posto que o tratamento depende de fatores físicos e hormonais e de um novo ciclo ovulatório, pugnou pela intimação da ré para desconsiderar o prazo assinalado.

Conquanto especificamente intimadas para tanto, as partes não demonstraram interesse na produção de novas provas (ID 79633695).

É o que importa relatar. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do quanto previsto no art.355, I, do CPC/2015, porquanto desnecessária a produção de outras provas. Destaque-se ainda que, conquanto intimadas para especificar as provas cuja produção tivessem interesse, **as partes nada requereram**.

O cerne da lide está adstrito à análise da legalidade da negativa de cobertura do procedimento objeto da lide e, em caso negativo, se há ocorrência de dano moral indenizável.

Os laudos médicos juntados aos autos (IDs 67738872, 70472393, 70472399 e 72411161) indicam que a parte autora precisa fazer uso de 5 (cinco) doses da medicação imunoglobulina humana 15 gramas, sendo 01 (uma) dose a cada 21 (vinte e um) dias, acrescida de clexane 40UI SC, durante a gravidez, conforme prescrição da médica assistente da parte autora (ID 67738872), com objetivo de evitar perda fetal no 1º (primeiro) trimestre gestacional, porquanto portadora de aloimunidade não reativa.

O contrato firmado entre as partes encerra relação de consumo, desafiando a aplicação da legislação consumerista, nos exatos termos do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça ("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão").

Além disso, ao caso também deve ser aplicada a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, no art. 10 preceitua que, *in verbis*:

> ***Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde**, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados*

exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, **das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,** *respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

VIII - revogado;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

§1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

*§***2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.**

§3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o §2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos.

§4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o plano-referência, que deverá ser obrigatoriamente oferecido por toda e qualquer operadora de contrato de assistência à saúde, deve necessariamente assegurar cobertura a todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ressalvadas as exclusões enumeradas nos incisos I a X.

No presente caso, segundo o laudo médico juntado aos autos (ID 18813130), a autora é portadora de doença que consta da lista da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a saber aloimunidade não reativa (Síndrome Antifosfolipede) - CID 10 D68.8, e que, portanto, possui cobertura pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes.

Não me impressiona o argumento de que a cobertura do tratamento em questão estaria excluída por força do art. 10, VI, da Lei 9.656/98, que desobriga os planos de saúde a fornecer medicamento para tratamento ambulatorial, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12.

Em casos tais, a negativa de fornecimento de fármaco para administração em ambiente ambulatorial levaria a situação de inaceitável iniquidade, em que o paciente haveria de permanecer em leito hospitalar, sob pena de lhe ser negada a cobertura, quando, na verdade, o tratamento se afigura mais eficaz se realizado independentemente de internação.

Nessas circunstâncias, cuido que a negativa de fornecimento de fármaco necessário ao tratamento de saúde do segurado ao argumento exclusivo de que "a cobertura para medicamento de uso ambulatorial apenas é obrigatória no caso de tratamento oncológico e imunobiológico" afigura-se abusiva.

Aliás, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que "é abusiva cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar" (STJ - AGARESP 201300290433, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04.04.013).

Outrossim, nos termos do art. 35-C, II, da Lei 9.656/98, as eventuais **"complicações no processo gestacional", especialmente no 1° (primeiro) trimestre, caracterizam regime de urgência**, possuindo cobertura obrigatória.

No caso, considerando que a enfermidade que acomete a autora pode acarretar perda fetal, tenho por evidenciada a complicação no processo gestacional e, em consequência, caracterizado o regime de urgência.

Não se olvide ainda que resta pacificado na jurisprudência do STJ que **somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente**, não estando a seguradora habilitada, nem tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o

restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. Isso porque a seguradora não pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica.

Assim, **se a patologia está prevista no contrato, não pode haver qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente e de sua patologia, por quem não detém técnica nem competência para fazê-lo.**

Confira-se:

> *"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n ° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia.* ***Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato.*** *Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n ° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n ° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02). Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a*

quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. ***É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor"*** *(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 29/06/2007).*

No mesmo sentido ainda STJ - Resp. 1.053.810-SP. Também é esse o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Pernambuco::

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SER MINISTRADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, E NÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. . AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos CDC do art. 47, do diploma consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em benefício do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, considerando a imposição unilateral das condições do contrato. Assim, devem ser declaradas suas ilegalidades e abusividades quando infringir direitos da parte hipossuficiente. 2.* ***Considerando a expressa cobertura contratual para obstetrícia, é ilegal a recusa de fornecimento do medicamento prescrito por profissional competente (Clexane 40 mg) para tratar a Trombofilia Hereditária que acomete a Agravante, sendo irrelevante a sua realização se dar em ambiente domiciliar.*** *3. Nos termos da jurisprudência do STJ: É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar. (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 4. Agravo a que se dá provimento. (AI 3811496-PE, TJPE, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Roberto da Silva Maia, j. em 04.08.2015)*

Ademais, observo que a ausência de inclusão do fármaco indicado pela médica assistente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não autoriza a negativa de cobertura.

À vista de tais considerações, ao tempo em que **tenho como injusta a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso** solicitado pelo médico assistente, **confirmo os efeitos da decisão antecipatória de tutela** deferida nos autos, e reconheço a procedência do pedido de condenação da demandada a custear o tratamento médico solicitado.

A pretensão de reparação civil por danos morais também merece acolhida.

Malgrado, em regra de princípio, o mero inadimplemento contratual seja insuficiente à configuração de danos extrapatrimoniais, a jurisprudência vem reconhecendo que a indevida recusa a cobertura de contrato de assistência à saúde pode sim ensejar a configuração de dano moral indenizável (STJ: AREsp 946150/SP; AREsp 919439/RJ; AREsp 708894/DF; AgInt no AREsp 1022746/RN; AgRg no AREsp 666568/RJ).

É que, se de um lado é certo que, no mais das vezes, o não cumprimento de obrigação contratual impõe prejuízos de ordem unicamente material, de outro, importa ver que, em determinadas circunstâncias, o descumprimento do contrato pode exacerbar a seara patrimonial, dando causa a uma violação dos direitos da personalidade, ao comprometimento da honra, da dignidade ou da intimidade da pessoa humana, ou mesmo deflagrando ou agravando séria e compreensível situação de angústia, insegurança, aflição ou dor psíquica e/ou física de quem já se acha com a saúde debilitada, como ocorreu *in casu*. Nessas situações, do descumprimento do contrato decorrerá também danos morais, e, dado que a Constituição da República adotou o princípio da reparação integral (art. 5º, V e X), além de responder pelas perdas e danos materiais (art. 389 do CC), o responsável pelo inadimplemento deverá indenizar também os danos extrapatrimoniais.

Certamente, a recusa na autorização do tratamento médico solicitado pela autora e prescrito pela sua médica assistente, em razão do diagnóstico de patologia, é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica da qual inexoravelmente já se achava acometida a paciente.

Em verdade, não há como deixar de reconhecer que a demandante, já extremamente desgastada física e emocionalmente, viu-se inesperadamente desamparada justamente por aquele que foi contratado e remunerado para ampará-la nessa circunstância.

Ora, quem se vincula a plano de saúde o faz em busca de segurança e confiança futura para os seus bens mais preciosos: a saúde e a vida. Assim, o descumprimento de contrato dessa natureza, ao frustrar tais expectativas, impingindo ao paciente a sensação de abandono, à toda evidência é capaz de causar-lhe profunda dor psíquica e sofrimento indenizável a título de dano moral.

À vista de tais considerações, tenho como configurados o dano moral e o dever de indenizar.

Fixo o valor da indenização.

A indenização em face do dano moral tem caráter reparatório e punitivo-pedagógico. De um lado, visa reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, objetiva impulsionar o ofensor a cercar-se de novos cuidados a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, visa impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados.

De realçar ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na fixação do quantum indenizatório de dano moral "[...] recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (Cfr. REsps. nºs. 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).

No caso dos autos, tenho que a empresa ré agiu com culpa grave, pois quando da negativa de autorização de cobertura de medicamento essencial para o tratamento da autora, tinha ciência de que a enfermidade que o acometia poderia resultar em dano grave à sua saúde e à sua gravidez. Inarredável a conclusão de que o descumprimento contratual foi voluntário e consciente, agindo a operadora com culpa grave.

Por outro lado, a ré é empresa de significativo porte financeiro. Indenização modesta em termos pecuniários certamente não a estimulará a revisar conceitos e comportamentos com o objetivo de não mais praticar a conduta ilícita. Ademais, indenizações módicas têm permitido que o fornecedor lucre com a ofensa moral, preferindo, aqui e ali, arcar com indenizações a aparelhar-se adequadamente segundo as exigências do mercado consumidor e as interpretações assentadas pelo Poder Judiciário.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando sobretudo as peculiaridades do caso, já bem delineadas, para garantir à segurada a justa reparação pelos danos sofridos, sem que esta incorra em enriquecimento ilícito, e ainda atenta ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À vista do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, ao tempo em que **julgo procedentes os pedidos** (art. 487, I do CPC/2015), **confirmo** os efeitos da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, e condeno a demandada a:

1. **arcar** integralmente com os custos relacionados ao tratamento médico prescrito pela médica assistente da autora, a saber: o fornecimento de 5 (cinco) doses da medicação imunoglobulina humana 15 gramas, conforme laudos médicos (IDs 67738872 70472393, 70472399 e 72411161);

2. **pagar** à parte autora a título de indenização por danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária (índices da tabela do Encoge), a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora (1% - um por cento ao mês - art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN), a partir da data da citação (art. 405 do CC);

3. **ressarcir** à autora o valor por ela depositado a título de adiantamento das custas e despesas processuais, a saber: **(i)** R$357,18 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), em 16.09.2020 (ID 68073663) e

(ii) R$322,44 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), em 13.04.2021 (ID 78561748), corrigido monetariamente (Encoge), a partir da data do efetivo desembolso;

4. **pagar** ao(s) advogado(s) constituído(s) pela parte autora honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, que deve incluir o valor do tratamento perseguido (condenação em obrigação de fazer referida no item 1) e o valor da condenação ao pagamento de indenização (item 2), levando-se em conta o zelo profissional e a complexidade da demanda, tudo com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 1.023, § 2º, do CPC/2015), e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões (art. 1010, §1º, do CPC/2015). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se a parte apelante para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §2º, do CPC/2015). Em seguida, com ou sem resposta, sigam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com os cumprimentos deste Juízo (art. 1010, §3º, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação.

Comunicações processuais necessárias.

Cumpra-se.

Recife, data da assinatura digital.

Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA
18/10/2022 12:33:14
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 117582633

22101812331396500000114936762

IMPRIMIR GERAR PDF